



Centre des opérations d'urgences de santé publique « COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16ème épidémie

SitRep MVE N° 39/MVE_16/2025

Pays/Province	RDC/Kasaï						
Zone de Santé touchée	BULAPE						
Date de rapportage	14 octobre 2025						
Date de publication	15 octobre 2025						
53	11	34	4,3 %	77,1 %	18	37 240	32 050
Cas Confirmés	Cas probables	Décès confirmés	Taux d'occupation des lits chez les confirmés	Taux d'occupation des lits chez les suspects	Guéris	Doses de vaccin déployées	Personnes vaccinées

I. POINTS SAILLANTS

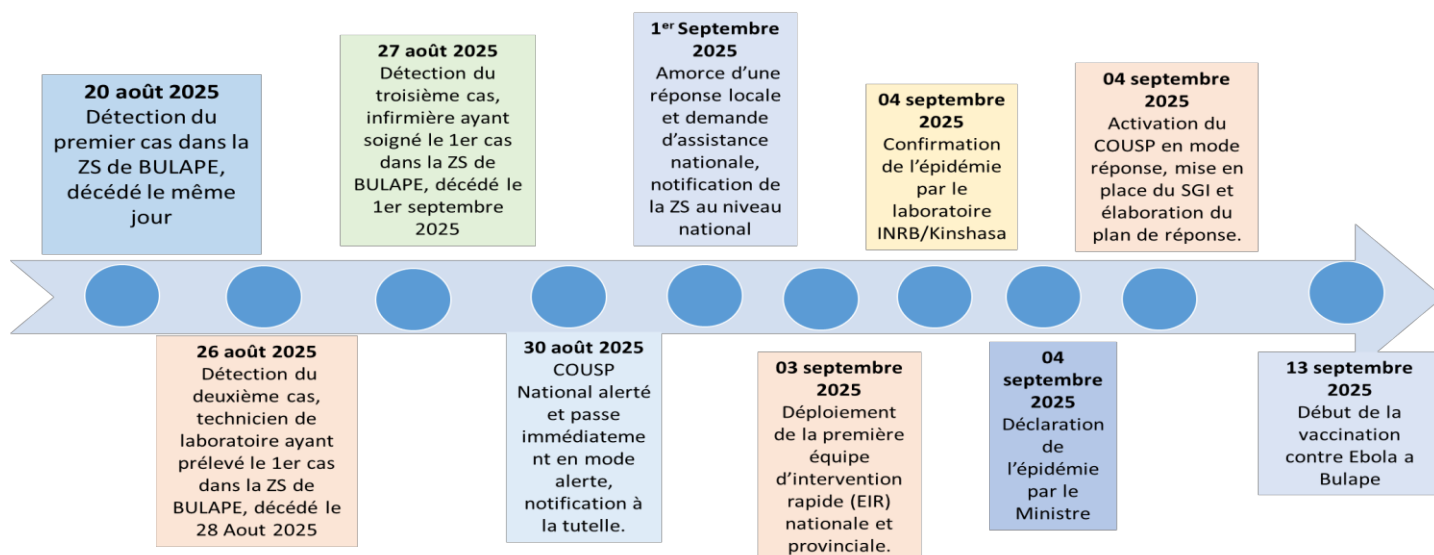
- ☒ Aucun nouveau cas n'a été confirmé en ce jour.
- ☒ 2ème jour de ratissage ce jour pour la stratégie géographique

NARRATIF DU CAS INDEX PRESUME (Contexte)

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 20 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.



II. CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS



III. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- ☑ Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié en date du 14/10/2025.
- ☑ La date de la dernière notification d'un cas confirmé remonte au 26 septembre 2025. Ainsi, nous sommes 18ème jour sans notification d'un cas confirmé.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 45 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 70,3% (Tableau I).
- ☑ La létalité parmi les cas confirmés est de 64,2% (34 décès/53 cas confirmés).
- ☑ Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure à 6 (28,6%) sur les 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 14 octobre 2025

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Date de notification du dernier cas confirmé	Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables		
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	20/09/2025	25
Bulape	0	16	14	87,5%	8	26/09/2025	18
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	20/09/2025	24
Dikolo	0	25	14	56%	1	26/09/2025	18
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	13/09/2025	29
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	22/09/2025	21
Total	0	53	34	64,2%	11		

**Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.*

Au 14/10/2025, la ZS de Bulape totalise 53 cas confirmés de MVE, dont 34 décès, soit une létalité de 64,2%. L'AS de Bulape Com. Enregistre la létalité la plus élevée avec 100%, suivie de Bulape (87,5%). Dikolo reste l'AS la plus touchée en terme des cas (25), avec une létalité de 56%. Aucune aire ne rapporte de nouveau cas confirmé depuis plusieurs jours, allant de 18 à 29 jours sans notification. On compte également 11 cas probables, majoritairement rapportés dans l'AS de Bulape.

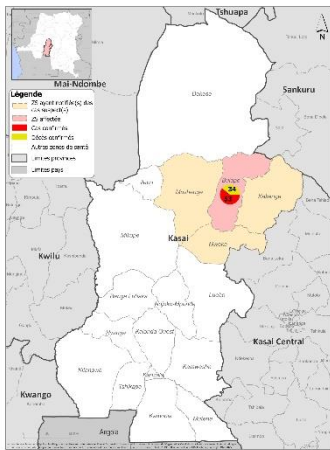


Fig 1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasai, au 14 octobre 2025

La ZS de Bulape demeure l'unique ZS avec des cas confirmés et des décès, sur l'ensemble des ZS ayant notifiés des cas suspects. A ce jour, la létalité est à 64,2%

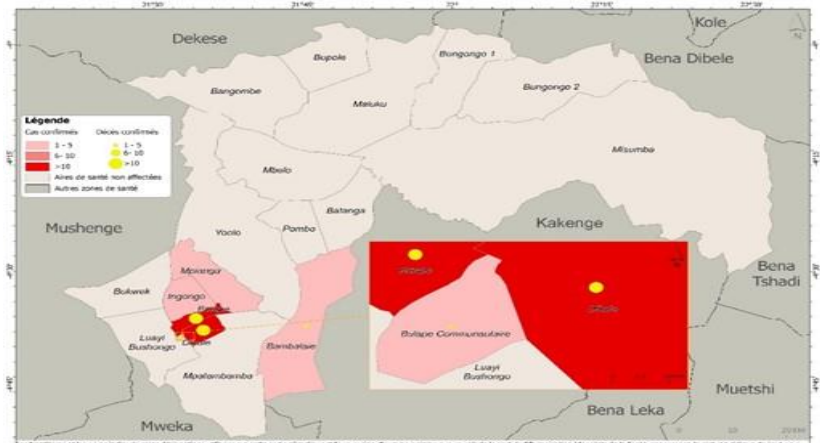


Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 14 octobre 2025

Les aires de santé de **Bulape** et de **Dikolo** sont les plus touchées, à la fois en terme du nombre de cas confirmés et des décès enregistrés.

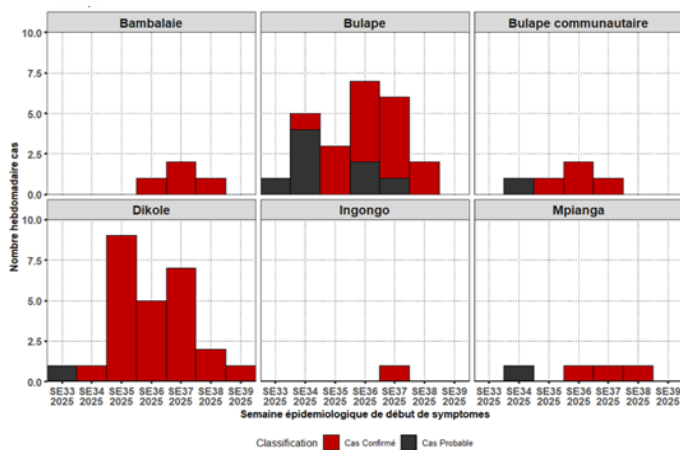


Fig 2. Répartition géographique des cas confirmés et probables par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 14 octobre 2025

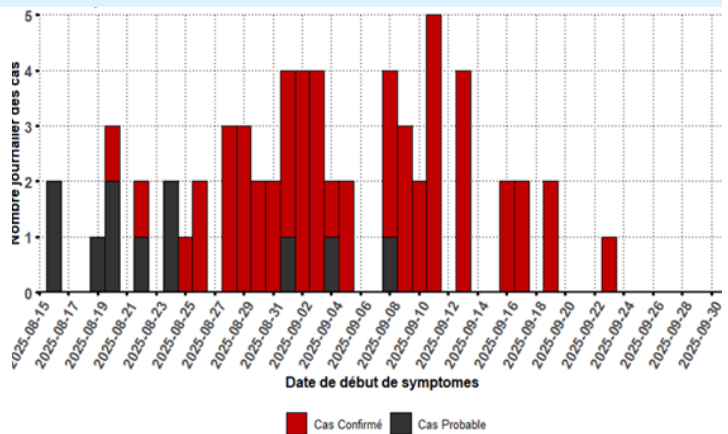


Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 14 octobre 2025.

En considérant les AS de BULAPE et DIKOLO comme principaux foyers de l'épidémie dans la ZS de Bulape, il ressort que durant les SE 35 à 36, l'AS de Dikolo a enregistré le plus grand nombre de cas notifiés. Cependant, à partir de la SE37 jusqu'au SE38, une tendance à la hausse des cas confirmés est observée dans l'AS de Bulape

Sur la période allant du 27 Aout au 13 septembre, l'analyse journalière met en évidence la survenue de trois clusters des cas confirmés. Par la suite, à compter du 15 septembre ; les notifications deviennent sporadiques, traduisant une diminution progressive de la transmission communautaire.

Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 14 octobre 2025

INDICATEURS	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	11/10/2025	12/10/2025	13/10/2025	14/10/2025
Report alertes	4	10	6	6	23	0	3
Nouvelles alertes signalées du jour	39	6	41	29	57	73	94
Total alertes du jour	43	16	47	35	80	73	97
Alertes investiguées du jour	32	10	33	23	80	70	97
Alertes validées du jour	20	6	16	12	24	16	29
Suspects prélevés	20	5	8	8	17	13	20
Transférés au CTE	10	5	4	8	17	13	20

NA : non applicable ; ND : non disponible

Le nombre moyen d'alertes journalières rapportées cours de 7 derniers jours (du 08/10/2025 au 14/10/2025) est de 56. Parmi les alertes du jour, deux MAPI ont été signalés.

Tableau 3. Synthèse de la situation du suivi de contacts au 14 octobre 2025

Aire de Santé	Suivi journalier						Taux de suivi	Total non vus	Raison de non vus						
	Report du 13/10/2025	Nouveaux contacts du 14/10/2025	Contact à suivre ce jour	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects			Simple Absence	Perdus de vue (≥72 heures)	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	Reste à suivre le jour suivant
Bambalayi	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulape	123	0	123	123	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	123
Bulape Com	31	0	31	28	0	0	90,32%	3	0	0	0	0	0	0	31
Dikolo	155	0	155	152	131	0	100%	0	0	0	0	0	3	0	24
Ingongo	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Mpianga	18	0	18	18	18	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	327	0	327	324	149	0	99,1%	3	0	0	0	0	3	0	178

Pour un ensemble de 327 contacts à suivre, 324 contacts ont été vus soit une proportion de suivi de 99%.
Trois (3) contacts sont en déplacement.

IV. ACTIONS DE REPONSE

COORDINATION

- ☒ Tenue de la réunion de coordination.

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- ☒ Répartition des acteurs du Pilier Surveillance (ACoDD, OMS et MSPHPS) dans toutes les 21 AS de la ZS de Bulape Continue.
- ☒ Déploiement d'une équipe multidisciplinaire à Bambalaie pour le suivi des cas de refus.
- ☒ Investigation des cas de mortalité animale (2 chèvres) dans l'AS Bulape.
- ☒ Poursuite des activités de routine (remontée des alertes, recherche active, investigations et suivi des contacts).
- ☒ Investigation des alertes notifiées par la RA lors de la descente de l'équipe conjointe dans l'AS Bukwek ;
- ☒ Investigation des cas de mortalité animale (un chien et un porc) dans l'AS Bulape.

Points sur la surveillance aux Points d'entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- ☒ Pour la journée du 14 octobre 2025, un total de 5 865 voyageurs ont été enregistrés dans les 5 PoC opérationnels (4 à Bulape et 1 à Luebo). Tous (100%) ont été screenés et ont procédé au lavage des mains. Deux alertes ont été signalée au cours de cette journée.

LABORATOIRE

- ☑ Pour la journée 14/10/2025, 24 échantillons ont été reçus 24 de BULAPE (18 nouveaux cas suspects, dont 1 swab et 6 reprélèvements). Tous les échantillons de reprélèvement sont revenus négatifs. Aucun nouvel échantillon des cas suspects n'est revenu positif.
- ☑ De tous les échantillons analysés depuis le début, 53 ont été diagnostiqués positifs à la MVE.

Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire du 13 octobre 2025

Indicateurs	Données
Échantillons reçus (total)	
Nouveaux cas suspects	18(1 swab)
Reprélèvements	6
Échantillons analysés	18
Reprélèvements analysés	6(Tous négatifs)
Résultats des tests	
En cours d'analyses	0
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	18
Total des cas confirmés	53

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 14 octobre 2025

CI/CT/CTE	Cas suspects				Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nouvelle admission	Total cas au terme de la journée	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	16	17	22	137,5%	18	1	4,3%	0	18
CT Bambalayi	10	0	3	30%	5	0	0%	0	0
CT Ingongo	5	0	2	40%	0	0	0%	0	0
CT Mpianga	4	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0
Total	35	17	27	77,1%	23	1	4,3%	0	18

- ☑ Au total, 27 cas suspects étaient hospitalisés à la fin de la journée, avec un taux d'occupation global de 77,1%. Le CTE de l'HGR Bulape est le plus sollicité, avec 22 cas suspects, dépassant sa capacité (137% de taux d'occupation des lits. Un seul cas confirmé est hospitalisé, soit 4,3% de taux d'occupation pour les cas confirmés.
- ☑ Aucun patient n'a été déclaré guéri ce jour
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 18 personnes ont été déclarées guéries et sorties du CTE et le traitement spécifique (Mab114/Ebanga) a été administré à 31 patients.

Activités phares du pilier

- ☒ Suivi résistance au prélèvement de 2 filles au CS Ndambo/ Bambalaie
- ☒ 83 ménages représentant 674 personnes (112 H, 127 F, 250 filles & 185 garçons) ont bénéficié du soutien psychoéducatif sur la MVE dans 3 quartiers parmi lesquels 16 ménages de guéris et de décédés
- ☒ Enquête sociale sur les enfants orphelins et suivi des activités de SMSPS dans 2 aires de sante (Ingongo & Mpianga)
- ☒ Briefing de 25 TPS additionnels dans 2 aires de sante (Dikolo & Bulape com)

1. PEC Médicale

- ☒ Tenues de la réunion technique avec les différents partenaires.
- ☒ Prise en charge des patients

2. PEC NUTRITIONNELLE

- ☒ Soutien alimentaire de 28 patients au CTE Bulape, CT Bambalaie et CT Ingongo.
- ☒ Suivi des 57 enfants de moins de 59 mois MAS dont 4 dans l'HGR Bulape et 53 dans les AS.
- ☒ Evaluation des aspects de la PEC nutritionnelle dans les CS.

3. CONTINUITE DES SERVICES

- ☒ Consultations pédiatriques (28 Enfants), nutritionnelles (4 enfants) et gynécologiques (5 femmes).
- ☒ Transfusion de 3 enfants. Le stock journalier est de 2 poches (La réquisition en produit sanguin est en cours).

PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- ☒ Poursuite de la décontamination et démantèlement de l'ancien CTE J6/7.
- ☒ Activités réalisées autour de l'alerte (revenu négatif) du CSR Kinda 1 dans la ZS de KAKENGÉ.
- ☒ Réalisation des évaluations PCI et accompagnement de 3 ESS sur l'Axe BUKWEK (PS IBONTSHI, PS BETANG YAW et PS MASANGU).
- ☒ Réalisation d'un EDS du décès survenu à l'HGR Bulape.
- ☒ Poursuite de la dotation des kits PCI dans 3 écoles (EP2 DISANGA, EP2 TSHITOKA et Complexe scolaire LA CONNAISSANCE).

VACCINATION

- ☒ Poursuite de la vaccination géographique.
- ☒ Ratissage à Mpianga, Ingongo et Bambalaie.
- ☒ 2è jour de ratissage ce jour pour la stratégie géographique
- ☒ 4 alertes au PS Kananga dans l'AS Bambalaie signalé par l'équipe de vaccination
- ☒ Mission conjointe avec la surveillance au village Mbamba Bishasha

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- ☒ Plaidoyer du Chef de groupement de Bambalaie et chefs des villages pour leur engagement dans la sensibilisation de la communauté sur les mesures préventives contre MVE ainsi l'utilisation des services de soin disponibles au centre de santé.
- ☒ Sensibilisation sur les mesures préventives de la MVE auprès de gardes malades au centre de santé Bambalaie. 80 personnes dont 50 femmes touchées.
- ☒ Sensibilisation sur l'adoption des mesures préventives de la MVE et l'importance de la scolarisation des enfants dans plusieurs écoles dont : Institut Katoka, ITA Mpembe, Institut Lola dans l'AS Mpata-Mbamba et ITM Bulape, EP Mbumba. Au total, 1,636 élèves dont 918 filles et 22 enseignants ont été sensibilisés.
- ☒ Sensibilisation autour des sites de vaccination.
- ☒ Descente dans les aires de santé de Mpatambamba et Bambalaie pour des activités CREC de préparation : Une équipe du CREC s'est rendue dans les AS de Mpatambamba et Bambalaie afin de planifier les activités de sensibilisation sur la promotion des mesures de prévention de la MVE. À l'occasion des séances de sensibilisation ont été organisées dans les écoles et au CS.
- ☒ Remontée d'une alerte d'un écolier de l'EP Bulape ayant présenté des vomissements.

LOGISTIQUE

- ☒ Appui logistique à l'équipe conjointe (Sécurité & Sureté, surveillance, PEC et CREC) vers Bulape
- ☒ Appui logistique aux interventions des équipes sur le terrain (PCI, Surveillance, PEC et Point d'entrée)
- ☒ Réception de 3 motos restantes de l'UNICEF

PSEA

- ☒ 2050 personnes, dont 815 filles et femmes ont été touchées par des sensibilisations communautaires sur les MGP des EAS, sur le circuit de référencement et l'assistance aux victimes ; dans les villages Tshikapa, Kalamba et Ndambo.
- ☒ Participation à la tribune populaire organisée conjointement avec la CREC.
- ☒ Sensibilisation des 30 U-Report (dont 4 filles) sur la PSEA.
- ☒ Distribution des affiches et des dépliants de sensibilisation sur la PSEA.
- ☒ 10 leaders religieux et 10 enseignants des 4 écoles du village Ndambo As bambalaie ont été sensibilisés.
- ☒ Sensibilisation de la communauté sur les mesures de PSEAH, y compris les mécanismes des signalements: 407 jeunes (175 filles) y ont pris part.

RECHERCHE

- ☒ **Identification de l'origine du virus et mode de transmission ;**
 - Évaluation des populations animales pouvant servir de réservoirs.
 - Contrôle de la faune pour limiter les contacts humains-animaux à risque.
- ☒ **Analyse des perceptions, comportements et facteurs socioculturels favorisant la transmission :**
 - Études sur la santé mentale et le bien-être des communautés affectées.
 - Recherche sur la stigmatisation des malades, survivants et des familles et du personnel de santé.
 - Analyse des liens entre Ebola, suicides et comportements suicidaires.

SURETE ET SECURITE

- ☒ Monitoring sécuritaire quotidien

IV. DEFIS ET GAPS

- ☒ Mauvais état de route pour atteindre les différents villages des AS affectées.
- ☒ Insuffisance des ressources pour la mise en place d'une réponse holistique.

V. RECOMMANDATIONS

- ☒ Poursuivre les investigations approfondies afin de déterminer la source de l'épidémie.
- ☒ Intensifier les activités de vaccination géographiques dans les villages des AS faiblement couverts
- ☒ Poursuivre la vaccination des contacts et la visite des campements en effectuant le suivi des contacts encore actifs

VI. PHOTOS DE TERRAIN

Briefing des IT, ITA et TL sur la surveillance de la MVE et la SBC



Sensibilisation de la population sur la détection précoce des alertes et la vaccination



**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnemwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : nganduchristian@ymail.com

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : Richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : elovainior@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: makeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int

